

Examen d'Anatomie pathologique

3^{ème} Année Médecine

Session normale

Durée 02h

Cochez les réponses Justes :

1. Un examen cytopathologique peut être réalisé à partir :

- A. D'un liquide céphalorachidien.
- B. D'un liquide pleural.
- C. De prélèvements fixés dans le formol.
- D. D'appositions d'un ganglion lymphatique, communiqué non fixé au laboratoire.
- E. D'un frottis d'exocol utérin.

2. Concernant la fixation tissulaire :

- A. La modalité de fixation habituelle des pièces opératoires est le séchage à l'air.
- B. La fixation est indispensable au maintien de la morphologie tissulaire.
- C. La fixation est en règle réalisée par le formol.
- D. La fixation correspond à la photographie d'une pièce opératoire.
- E. La fixation évite l'autolyse spontanée des tissus.

3. L'examen anatomopathologique extemporané effectué au cours d'un acte chirurgical :

- A. Est réalisé sur un prélèvement tissulaire fixé dans du formol.
- B. Nécessite l'inclusion en paraffine du prélèvement fixé.
- C. Permet de fournir un diagnostic rapide susceptible de modifier le déroulement d'un acte chirurgical.
- D. Peut-être indiqué pour vérifier, au cours de l'acte chirurgical, la qualité des limites d'exérèse.
- E. Est demandé pour faire une étude immunohistochimique.

4. L'Adénofibrome du sein est :

- A. Une tumeur de la femme âgée.
- B. Une prolifération tumorale monoclonale.
- C. Une prolifération tumorale glandulaire et conjonctive.
- D. Fait de canaux avec des cellules myoépithéliales externes.
- E. Une prolifération exclusivement mésenchymateuse.

5. Quels sont les facteurs associés au risque de cancérisation d'un polype adénomateux colique ?

- A. Un nombre plus élevé de lésions.
- B. Une taille plus grande du polype.
- C. Une proportion plus élevée de l'architecture villose.
- D. Une proportion plus élevée de l'architecture tubulaire.
- E. L'étendue de la dysplasie de haut grade.

6. La matrice extracellulaire :

- A. Détermine la qualité du tissu conjonctif.
- B. Est incriminée dans le processus inflammatoire.
- C. Est délimitée par la membrane basale qui en est une composante.
- D. Ne comporte pas des capillaires sanguins.
- E. Est une des composantes du tissu osseux.

7. La matrice interstitielle :

- A. Est en remodelage continue.
- B. Peut favoriser l'invasion tumorale.
- C. Ne fait pas partie de la matrice extracellulaire.
- D. Comporte une substance fondamentale dont la proportion varie selon le siège anatomique.
- E. Est riche en glycoprotéines.

8. Dans le métabolisme des pigments :

- A. Les troubles sont intra et extra cellulaires.
- B. La choléstase hépatique n'est pas liée à un obstacle dans les voies biliaires.
- C. La surcharge en fer est toujours primitive.
- D. Les amas de bile intra hépatocytaire est l'expression histologique de la choléstase.
- E. Les troubles du métabolisme du fer peuvent se voir au niveau du pancréas.

9. Le thrombus mixte est :

- A. La variété la plus habituelle des thrombus.
- B. De structure complexe, présentant une tête blanche et un corps stratifié.
- C. Observé dans les capillaires et les petites artères.
- D. Observé dans les vaisseaux de grand et moyen calibre.
- E. Composé toujours d'un corps rouge.

10. Microscopiquement, la tuberculose folliculaire renferme :

- A. Des cellules épithélioïdes.
- B. Des cellules de type Langhans.
- C. Des follicules centrés de nécrose caséuse.
- D. Une couronne lymphocytaire.
- E. Des follicules épithélio-giganto-cellulaires sans nécrose caséuse.

11. L'analyse histologique des tumeurs mésenchymateuses apprécie :

- A. La morphologie des cellules tumorales et l'existence d'une éventuelle différenciation.
- B. La taille de la tumeur.
- C. L'aspect macroscopique de tumeur.
- D. L'aspect de la vascularisation et du stroma.
- E. La présence de remaniements nécrotiques et/ ou hémorragiques.

12. Concernant les tumeurs vasculaires :

- A. Les lymphangiomes sont des tumeurs vasculaires malignes.
- B. Les hémangiomes sont des tumeurs vasculaires malignes.
- C. Les hémangiomes capillaires sont constitués de grandes cavités vasculaires anastomosées.
- D. Le sarcome de kaposi est une tumeur vasculaire maligne, associé à l'infection par le virus HHV8.
- E. L'angiosarcome est une tumeur vasculaire maligne.

13. La différenciation tumorale désigne : 9, -

- A. Le nombre de mitoses.
- B. Le degré de ressemblance histologique avec le tissu d'origine.
- C. Un facteur histopronostique.
- D. La présence ou non de métastases.
- E. Toutes les réponses sont justes.

14. Le ki67 :

- A. Précise le type histologique.
- B. Est un marqueur épithélial.
- C. Est un marqueur mésenchymateux.
- D. Est un marqueur pronostique.
- E. Est un indice mitotique.

15. Le tableau histologique d'une maladie auto-immune comporte :

- A. Une fibrose tissulaire.
- B. Une atrophie des structures épithéliales tissulaires.
- C. Un infiltrat inflammatoire fait toujours de polynucléaire neutrophile.
- D. Un infiltrat inflammatoire fait exclusivement de lympho-plasmocytes.
- E. Des lésions de vascularite toujours présentes.

16. Le rejet aigu d'un greffon hépatique se présente par :

- A. Des lésions de portite.
- B. Une fibrose hépatique.
- C. Une cholangite.
- D. Une ductopénie.
- E. Des lésions d'endothélite.

17. Le paraganulome nodulaire de Poppema et Lennert :

- A. Est un Lymphome Hodgkinien.
- B. Est un lymphome Non Hodgkinien de type B.
- C. Caractérisé par la présence de cellules tumorales en Pop-corn.
- D. Caractérisé par la présence de cellules réactionnelles de type lymphocytaire.
- E. Peut évoluer vers un LMNH de type B.

18. Les cellules tumorales dans le lymphome de Hodgkin sont :

- A. Des cellules de grande taille mononucléées.
- B. Des cellules binucléées.
- C. Des cellules momifiées.
- D. Des lymphocytes.
- E. Des plasmocytes.

19. En évolution clonale, le processus de la carcinogénèse passe par ces étapes :

- A. La progression.
- B. Les métastases à distance.
- C. L'initiation.
- D. La promotion.
- E. La constitution du stroma tumoral.

20. Les lésions d'athérosclérose se localisent au niveau :

- A. Des grosses veines.
- B. Des artères élastiques.
- C. Des veinules et artéioles afférentes.
- D. Des coudures et des bifurcations des collatérales.
- E. Veines hépatiques.

21. Quelles sont les complications ultimes de l'athérosclérose ?

- A. L'anévrysme.
- B. L'AVC secondaire à une embolie.
- C. L'infarctus du myocarde.
- D. Les varices des membres inférieurs.
- E. La rupture de la veine cave inférieure.

22. Dans l'infection herpétique, on retrouve :

- A. Du caséum en « fromage blanc ».
- B. Des vésicules avec du liquide séreux en Intra épidermique.
- C. Des lésions de tuberculose.
- D. Une fibrose d'encorbeillement.
- E. Des inclusions intra nucléaires volumineuses.

23. La métastase à distance se caractérise par :
- A. Un autre type histologique différent de la tumeur primitive.
 - B. Une tumeur plus différenciée ou moins différenciée que la tumeur primitive.
 - C. Un envahissement lymphatique et vasculaire.
 - D. Une résistance fréquente au traitement.
 - E. Des lésions de CIS.
24. Concernant le Néphroblastome, quelles affirmations sont correctes ?
- A. Il s'agit de la tumeur rénale la plus fréquente chez l'adulte.
 - B. Il touche principalement l'enfant avant l'âge de 5 ans.
 - C. Son traitement repose uniquement sur la chirurgie.
 - D. Il peut contenir des structures différenciées comme des glomérules rudimentaires.
 - E. Il présente souvent des métastases pulmonaires.
25. À propos des mélanomes, quelles affirmations sont exactes ?
- A. Ils apparaissent uniquement sur une peau saine.
 - B. Ils ne donnent jamais de métastases.
 - C. Leurs contours sont généralement réguliers.
 - D. Ils sont constitués d'une prolifération de mélanocytes présentant un aspect pléomorphe.
 - E. Leur pronostic est étroitement lié à leur profondeur d'invasion, évaluée par l'indice de Breslow.
- Cochez-la réponse juste :
26. Dans la phase algüe de l'inflammation, l'œdème inflammatoire :
- A. Est un phénomène passif.
 - B. Est un transsudat.
 - C. Est lié à une augmentation de la perméabilité des parois vasculaires.
 - D. Entraîne une concentration des produits toxiques.
 - E. Entraîne une accélération du courant circulatoire.
27. La contraction du tissu de réparation au cours de la phase de cicatrisation est liée à l'action des :
- A. Macrophages.
 - B. Lymphocytes.
 - C. Myofibroblastes.
 - D. Cellules géantes multinucléées.
 - E. Fibroblastes.
28. Quelle caractéristique distingue principalement un adénome d'un adénocarcinome ?
- A. Présence de structures glandulaires.
 - B. Invasion du stroma adjacent.
 - C. Production de mucus.
 - D. Absence de néovascularisation.
 - E. Localisation dans le tractus gastro-intestinal.
29. Les troubles du métabolisme des protides :
- A. Sont seulement liés à la synthèse et l'excrétion.
 - B. Se manifestent uniquement par des dépôts inter cellulaires.
 - C. Engendrent entre autres des dépôts amyloïdes.
 - D. N'affectent jamais les reins.
 - E. Epargnent le cœur.
30. Quelle est la variété d'embolie la plus fréquente ?
- A. Gazeuse.
 - B. Parasitaire.
 - C. Suppurée.
 - D. Graisseuse.
 - E. Cruorique.
31. Un abcès se distingue d'un phlegmon par :
- A. Sa richesse en Polynucléaires.
 - B. La présence de Polynucléaires altérés.
 - C. L'aspect collecté de la lésion.
 - D. L'absence de polynucléaires altérés.
 - E. Les dépôts fibrineux.

32. Parmi les propositions suivantes quel est le terme qui désigne un état précancéreux ?
 A. L'hypertrophie. B. L'atrophie. C. La dysplasie.
 D. La dystrophie. E. La dégénérescence cellulaire.
33. Parmi les éléments suivant indiquez celui qui définit le carcinome in situ ?
 A. L'hypertrophie épithéliale.
 B. L'hyper vascularisation.
 C. Une réaction inflammatoire péri lésionnelle.
 D. L'absence de dépassement de la basale épithéliale.
 E. L'érosion en surface.
34. Toutes ces substances peuvent déclencher une vasodilatation sauf une, laquelle ?
 A. Les Kinines. B. L'histamine. C. La sérotonine.
 D. L'opsonine. E. Les prostaglandines.
35. Parmi ces virus, lesquels sont oncogènes ?
 A. Virus de l'hépatite B (HBV).
 B. Virus Epstein Barr (EBV).
 C. Human T-lymphotropique virus (HTLV1).
 D. Human papilloma virus (HPV 16, 18).
 E. Toutes les propositions sont justes.
36. Dans le stade d'invasion locale du cancer, l'envahissement des cellules cancéreuses de proche en proche est défini comme :
 A. Une extension par contiguïté.
 B. Une extension par migration à distance.
 C. Des emboles vasculaires.
 D. Des engainements péri nerveux.
 E. Une métastase.
37. Concernant l'apoptose, quelle affirmation est fausse ?
 A. Elle est un phénomène physiologique programmé.
 B. Elle implique une activation de gènes spécifiques.
 C. Elle s'accompagne d'une réaction inflammatoire.
 D. Elle joue un rôle dans l'élimination des cellules indésirables.
 E. Les cellules apoptotiques sont phagocytées sans rupture membranaire.
38. Quelle tumeur embryonnaire est souvent héréditaire et liée à une mutation du gène RB ?
 A. Neuroblastome. B. Rétinoblastome. C. Néphroblastome.
 D. Hépatoblastome. E. Tumeur vitelline.
39. La maladie de Bowen est :
 A. Une dysplasie de haut grade.
 B. Un carcinome basocellulaire in situ.
 C. Un carcinome épidermoïde in situ.
 D. Une dysplasie de bas grade.
 E. Un carcinome épidermoïde du col utérin.
40. Le carcinome de type transitionnel a pour point de départ :
 A. La prostate. B. La trachée. C. Le larynx.
 D. Le bassin. E. La vessie.

Bon courage